Sepsis y choque séptico en adultos: lo que cambió con la Surviving Sepsis Campaign 2026

Basada en las guías internacionales Surviving Sepsis Campaign (SSC) 2026 de la SCCM y la ESICM (fuente principal; 129 declaraciones), contrastadas con la versión 2021 y con las definiciones Sepsis-3 (JAMA 2016). La sección de perfusión se complementa con la revisión de Castro y cols. sobre los mecanismos del llenado capilar prolongado (Crit Care 2026). Se citan desde su texto original los ensayos ADRENAL, APROCCHSS, CLOVERS, BLING III, ANDROMEDA-SHOCK-2 y REVISE. La sección 4 (antimicrobiano por foco) no proviene de la SSC: resume las guías ATS/IDSA 2019 y ATS 2025 de neumonía comunitaria, IDSA/ATS 2016 de neumonía nosocomial, IDSA 2025 de infección urinaria complicada, e IDSA 2024 y SIS 2024 de infección intraabdominal.

Versión 1.1 · 3 de noviembre de 2026 · Equipo editorial de Medicina en Resumen · Cada criterio y cifra verificados contra la fuente original

1 h · 3 h
antimicrobiano en choque (posible, probable o definido) o en sepsis probable o definida · en sepsis posible sin choque, tras evaluación rápida, si persiste la sospecha

65 · 60–65
mm Hg de PAM inicial en choque séptico (fuerte) · rango sugerido en personas de ≥65 años (condicional, nueva)

–25/1,000
muertes con infusión prolongada de betalactámicos vs. bolo (RR 0.91; 18 ECA, 9,108 personas): ahora recomendación fuerte

LO QUE TIENES QUE SABER

- **Tamizaje:** usa NEWS, NEWS2, MEWS o SIRS en lugar de qSOFA como herramienta única (fuerte). La sepsis es un diagnóstico clínico: ningún biomarcador aislado la confirma ni la descarta.[1]
- **Hemocultivos** lo antes posible, idealmente antes del antimicrobiano, pero sin retrasarlo (fuerte, nueva).[1]
- **Antimicrobiano:** inmediato, idealmente en <1 h, en choque o sepsis probable o definida (fuerte). En sepsis posible sin choque: evaluación rápida y, si persiste la sospecha, en <3 h (condicional). Sin cambio respecto a 2021.[1]
- **Espectro a la medida:** cubre un patógeno multirresistente solo si hay riesgo de ese patógeno; no uses antifúngico ni cobertura de anaerobios de rutina. Betalactámico en infusión prolongada tras dosis de carga (fuerte) y desescalamiento con cultivo y antibiograma (fuerte).[1]
- **Reanimación:** ≥30 mL/kg de cristaloide (de preferencia balanceado) en 3 h y vasopresor si persiste la hipotensión; norepinefrina por vía periférica sin esperar el catéter central; PAM de 65 mm Hg (60–65 si ≥65 años). Guíate por medidas dinámicas, lactato seriado y llenado capilar.[1]
- **Adyuvantes:** corticoides IV en choque séptico y vasopresina si la norepinefrina va en ascenso (condicionales). Nuevas sugerencias en contra: antipiréticos para mejorar desenlaces, vitamina D, β-bloqueadores y probióticos; la vitamina C sigue en contra.[1]

1 Definiciones, terminología y tamizaje
2 La primera hora
3 Antimicrobianos: espectro, administración y duración
4 Antimicrobiano empírico por foco (fuera de la SSC)
5 Reanimación hemodinámica
6 Terapias adyuvantes
7 Ventilación y otros cuidados de soporte
8 Metas de cuidado y después del alta
9 Qué cambió respecto a 2021
10 Lo que estás haciendo mal
11 Casos y consulta rápida

1 Definiciones, terminología y tamizaje[1,3]

SEPSIS-3 (2016)

- **Sepsis:** disfunción orgánica que pone en riesgo la vida, causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Operativamente, aumento del SOFA ≥2 puntos (mortalidad hospitalaria >10 %).[3]
- **Choque séptico:** subgrupo con alteraciones circulatorias, celulares y metabólicas profundas. Clínicamente: vasopresor para mantener PAM ≥65 mm Hg y lactato >2 mmol/L (>18 mg/dL) sin hipovolemia; mortalidad hospitalaria >40 %.[3]
- **qSOFA** (≥2 de: FR ≥22/min, alteración mental, PAS ≤100 mm Hg): se propuso como predictor de mal desenlace, no como herramienta de tamizaje.[1,3]
- La SSC 2026 adopta Sepsis-3, pero pide un diagnóstico clínico integral y adaptado a los recursos locales.[1]

TAMIZAJE (SSC 2026)

- **Hospital:** NEWS, NEWS2, MEWS o SIRS en lugar de qSOFA como herramienta única (**fuerte, certeza moderada**). Un qSOFA positivo debe alertarte; en el ensayo SCREEN (60,055 personas), una alerta electrónica basada en qSOFA redujo la mortalidad hospitalaria a 90 días (RRa 0.85).[1]
- **Ambulancia o traslado aéreo:** usar una herramienta estandarizada (condicional, muy baja; nueva), sin preferir una. NEWS2 tuvo el mejor desempeño (sensibilidad 73.1 %, especificidad 81.6 %, VPP 6.5 %); qSOFA, la menor sensibilidad (23.1 %).[1]
- **Programa hospitalario** de mejora del desempeño (tamizaje, procedimientos estandarizados y mejora de la calidad): fuerte. Protocolo "código sepsis" con valoración multidisciplinaria a pie de cama: condicional, baja (nueva).[1]

TERMINOLOGÍA SSC 2026	DEFINICIÓN	QUÉ CAMBIA EN LA CONDUCTA
Sepsis definida	Confirmada por historia, exploración y estudios; diagnóstico alternativo muy poco probable.	Antimicrobiano inmediato (<1 h).
Sepsis probable	Sospecha alta: es el diagnóstico más probable; otro diagnóstico es menos probable.	Antimicrobiano inmediato (<1 h).
Sepsis posible	Sospecha moderada: la sepsis es posible, pero otro diagnóstico también es probable.	Sin choque: evaluación rápida; antimicrobiano en <3 h si persiste la sospecha. Con choque: <1 h.
Sepsis poco probable	Sospecha baja: la evaluación no concuerda con sepsis o hay un diagnóstico alternativo más probable.	Sin choque: diferir el antimicrobiano y vigilar de cerca.

Tabla 3 de la guía. Entre 10 y 30 % de quienes reciben tratamiento inicial por sepsis termina con un diagnóstico no infeccioso o no bacteriano.[1]

BIOMARCADORES Y PRUEBAS RÁPIDAS

- La sepsis no se confirma ni se descarta con un solo biomarcador o prueba (buena práctica, nueva).[1]
- **Pruebas novedosas de respuesta del huésped** (p. ej., ancho de distribución de monocitos, transcritos de ARNm): evidencia insuficiente (nueva). Clasifican el riesgo, no dan un resultado positivo o negativo; aportan poco si la probabilidad clínica ya es >90 %.[1]
- **Procalcitonina para iniciar** antimicrobiano: se sugiere la evaluación clínica sola en vez de procalcitonina más evaluación clínica (condicional, muy baja; sin cambio).[1]

LACTATO

- **Medir lactato** en sepsis posible, probable o definida (condicional, baja; sin cambio).[1]
- El umbral histórico para reanimar fue ≥4 mmol/L, pero la elevación intermedia (>2 a <4) es frecuente, se asocia con mayor mortalidad, coincide con el umbral de Sepsis-3 y puede beneficiarse de líquidos: considéralos si no hay contraindicación.[1]

2 La primera hora[1]

La sepsis y el choque séptico son urgencias médicas: el tratamiento y la reanimación deben empezar de inmediato (buena práctica). El antimicrobiano temprano es, junto con los líquidos, la intervención inicial más eficaz para reducir la mortalidad; la asociación es más fuerte y consistente en el choque.[1]

ESCENARIO	QUÉ HACER	FUERZA · CERTEZA
Choque séptico posible, probable o definido	Antimicrobiano inmediato, idealmente en la primera hora desde el reconocimiento.	Fuerte · muy baja
Sepsis probable o definida sin choque	Antimicrobiano inmediato, idealmente en la primera hora.	Fuerte · muy baja

ESCENARIO	QUÉ HACER	FUERZA · CERTEZA
Sepsis posible sin choque	Evaluación rápida y acotada de causas infecciosas y no infecciosas (buena práctica); si la sospecha persiste, antimicrobiano en <3 h desde que se sospechó. Si la causa bacteriana se vuelve la más probable, no esperes las 3 h.	Condicional · muy baja
Probabilidad baja de infección, sin choque	Diferir el antimicrobiano y vigilar de cerca.	Condicional · muy baja
Prehospitalario (nueva)	Sepsis probable o definida con hipotensión (p. ej., PAS <90, PAM <65 o PAS <100 en hipertensos) y >60 min previstos hasta la valoración hospitalaria: antimicrobiano en la ambulancia, solo si existe un proceso estructurado de tamizaje prehospitalario.	Condicional · muy baja

La certeza es muy baja (estudios observacionales con confusión residual y definiciones variables del tiempo cero), pero las recomendaciones de tiempo se mantienen sin cambio respecto a 2021. Un consenso Delphi para entornos de recursos limitados propone no demorar el antimicrobiano en sepsis posible sin choque si no hay laboratorio o imagen para descartar otra causa.[1]

HEMOCULTIVOS (FUERTE, BAJA; NUEVA)

- En sepsis posible, probable o definida, tómalos lo antes posible e idealmente antes del antimicrobiano, sin retrasarlo, sobre todo si hay hipotensión.[1]
- Se identifica patógeno en 60–70 % de las sepsis, pero los hemocultivos son positivos solo en 10–20 % (≥50 % en el choque séptico).[1]
- En general, dos sitios con 10 mL por frasco (en un estudio, sensibilidad de 91.5 % con un juego frente a 99.3 % con dos); un solo sitio es lo que recomienda la guía alemana de 2025, y un solo juego se justifica en recursos limitados. El frasco anaerobio se individualiza.[1]
- El antimicrobiano previo baja el rendimiento: positividad de 31.4 % antes vs. 19.4 % a una mediana de 70 min después.[1]
- Repite cultivos para documentar depuración en *S. aureus*, *S. lugdunensis* y *Candida*; toma cultivos del sitio sospechado.[1]

CONTROL DEL FOCO

- Busca rápido un diagnóstico anatómico o foco que requiera control urgente (buena práctica).[1]
- **Control temprano, idealmente en <6 h** desde el diagnóstico de sepsis o choque que lo requiere (condicional, muy baja; en 2021 era buena práctica). Más temprano es mejor cuando sea factible.[1]
- **Ejemplos:** abscesos intraabdominales o pélvicos, peritonitis por perforación, colangitis, colecistitis, pielonefritis con obstrucción o absceso, infección necrosante de tejidos blandos, empiema, artritis séptica y dispositivos infectados, incluidos catéteres centrales.[1]
- Los intentos prolongados de estabilización médica sin control del foco en el choque séptico difícilmente tienen éxito.[1]

EN PARALELO DURANTE LAS PRIMERAS HORAS[1]

- **Líquidos:** hipoperfusión inducida por sepsis o choque → ≥30 mL/kg de cristaloide IV en las primeras 3 h (condicional, baja), con reevaluación frecuente (sección 5).
- **Vasopresor:** si la hipotensión persiste tras el bolo inicial; de inmediato y junto con los líquidos en el choque inestable, caso por caso (condicional, muy baja; nueva).
- **Ingreso a la UCI:** si lo requiere, en las primeras 6 h (condicional, baja; sin cambio).

3 Antimicrobianos: espectro, administración y duración[1]

COBERTURA EMPÍRICA	RECOMENDACIÓN SSC 2026	FUERZA · CERTEZA
Patógeno multirresistente (MDR) específico (nueva)	**Alto riesgo:** cubrirlo. **Bajo riesgo:** no cubrirlo. Factores de riesgo: colonización o infección previa por ese patógeno (en el último año), uso prolongado de antibióticos de amplio espectro y hospitalización prolongada en una unidad con alta prevalencia de ese patógeno. Incluye *A. baumannii*, productores de BLEE, enterobacterias resistentes a carbapenémicos, enterococo resistente a vancomicina, *Pseudomonas* MDR y *S. aureus* resistente a meticilina (SARM).	Condicional · muy baja (ambas)
Antifúngico	No usarlo de rutina. Considerarlo caso por caso con factores de riesgo: inmunosupresión, antibióticos prolongados, hospitalización prolongada y foco intraabdominal.	Condicional en contra · baja

COBERTURA EMPÍRICA	RECOMENDACIÓN SSC 2026	FUERZA · CERTEZA
Anaerobios (nueva)	**Sin factores de riesgo:** esquema sin cobertura de anaerobios. **Con factores de riesgo** (foco intraabdominal o ginecoobstétrico profundo, infección necrosante de tejidos blandos, cabeza y cuello, absceso o empiema del SNC): incluirla. Si se necesita cobertura MDR, son aceptables fármacos con actividad anaerobia (p. ej., piperacilina con tazobactam o carbapenémicos) cuando las alternativas sin ella no bastan.	Condicional · muy baja (ambas)
Pruebas rápidas por patógeno (PCR, paneles sindrómicos, detección de resistencia; nueva)	Caso por caso, según clínica, epidemiología local, estacionalidad, disponibilidad y programa de optimización de antimicrobianos. Su beneficio aparece cuando se acompañan de un programa de optimización.	Condicional · baja
Biomarcadores de *Candida* (β-D-glucano, manano; nueva)	No usarlos para decidir iniciar ni para suspender el antifúngico empírico; considerar caso por caso en alto riesgo.	Condicional en contra · baja
Vigilancia microbiológica de vía aérea superior en toda la UCI (nueva)	Evidencia insuficiente para recomendar o no.	Sin recomendación

El beneficio de la cobertura MDR (mortalidad OR 0.71, muy baja) se debió a los datos observacionales de SARM. La guía no elige antibióticos: remite a ESCMID e IDSA y a infectología o microbiología. A diferencia de 2021, **no hay recomendación específica sobre doble cobertura de gramnegativos**.[1,2]

CÓMO ADMINISTRAR

- **Betalactámicos en infusión prolongada** (extendida durante al menos la mitad del intervalo, o continua) tras una dosis de carga, en lugar de bolo de ≤30 min (**fuerte**; la declaración indica certeza moderada, aunque el texto califica el metanálisis como de certeza alta). Mortalidad RR 0.91 (25 muertes menos por 1,000) en el metanálisis de la guía.[1] **BLING III** (7,031 adultos en UCI con piperacilina-tazobactam o meropenem; infusión continua de 24 h vs. intermitente de 30 min, misma dosis diaria): mortalidad a 90 días 24.9 vs. 26.8 % (OR 0.91; IC 95 % 0.81–1.01; p = 0.08, **no significativa** por sí sola); curación clínica 55.7 vs. 50.0 %.[8]
- Mayor beneficio con vidas medias cortas (piperacilina con tazobactam, carbapenémicos); cuida estabilidad y compatibilidad.[1]
- **Monitoreo de concentraciones** caso por caso, si está disponible (condicional, muy baja): depuración renal aumentada, LRA, hipoalbuminemia, reemplazo renal y soporte extracorpóreo las alteran.[1]
- **Descontaminación digestiva selectiva** en personas ventiladas, en unidades con baja prevalencia de resistencia (condicional, moderada; nueva): mortalidad RR 0.91 y menos resistencia (RR 0.64).[1]

DESESCALAR, SUSPENDER Y DURACIÓN

- Reevalúa de forma continua y **suspende** el empírico si se demuestra o se sospecha fuertemente otra causa (buena práctica).[1]
- **Desescala** (suspender lo innecesario o reducir el espectro) con diagnóstico microbiológico y antibiograma: **fuerte**, muy baja (sube desde sugerencia en 2021).[1]
- Sin patógeno en los cultivos finales y con mejoría: desescalar (condicional, muy baja). Con laboratorio limitado y alta prevalencia de MDR, pondera el riesgo de un MDR no detectado.[1]
- **Duración:** con diagnóstico inicial de sepsis y control adecuado del foco, más corta en lugar de más larga (condicional, muy baja). BALANCE: 7 días no inferior a 14 en bacteriemia.[1]
- **Procalcitonina para suspender**, junto con la clínica, cuando la duración óptima no es clara (condicional, baja; reforzada por ADAPT-Sepsis).[1]

4 Antimicrobiano empírico por foco (fuera de la SSC)[11–18]

ESTA SECCIÓN NO PROVIENE DE LA SSC

- La SSC 2026 no da guía específica para elegir antibióticos (queda fuera de su alcance) y remite a las guías de ESCMID e IDSA sobre patógenos MDR y a infectología o microbiología.[1] Aquí resumimos los esquemas empíricos para presentaciones graves o en la UCI de guías específicas (ATS/IDSA, IDSA, SIS). Cada sociedad usa su propia escala de fuerza y calidad; SIS: 1 = fuerte, 2 = débil; A = alta, B = moderada, C = baja.
- **Gramnegativos resistentes** (BLEE, productores de carbapenemasa, *Pseudomonas* de difícil tratamiento): consulta nuestra guía en resumen "Gramnegativos resistentes (IDSA 2026)". Dosis tal como las dan las guías; ajústalas a la función renal y a tu epidemiología local.

FOCO	ESQUEMA EMPÍRICO (GRAVE O EN LA UCI)	MODIFICADORES	DURACIÓN
Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) grave ATS/IDSA 2019; ATS 2025	Sin factores de riesgo de SARM ni *Pseudomonas*: **betalactámico + macrólido** (fuerte, moderada) o **betalactámico + fluoroquinolona respiratoria** (fuerte, baja). Betalactámico: ampicilina-sulbactam 1.5–3 g c/6 h, cefotaxima 1–2 g c/8 h, ceftriaxona 1–2 g/día o ceftarolina 600 mg c/12 h; macrólido: azitromicina 500 mg/día o claritromicina 500 mg c/12 h; fluoroquinolona: levofloxacino 750 mg/día o moxifloxacino 400 mg/día.[11] NAC grave = 1 criterio mayor (choque con vasopresor o ventilación mecánica) o ≥3 menores.[11]	Cubrir SARM o *Pseudomonas* solo si hay factores de riesgo validados localmente (fuerte, moderada); se abandona la categoría "neumonía asociada a los cuidados de la salud". En NAC grave con aislamiento respiratorio previo, u hospitalización reciente con antibiótico parenteral (90 días) más factores de riesgo locales: agregar cobertura y tomar cultivos (y PCR nasal para SARM) para desescalar. SARM: vancomicina 15 mg/kg c/12 h (ajustar por niveles) o linezolid 600 mg c/12 h. *Pseudomonas*: piperacilina-tazobactam 4.5 g c/6 h, cefepima 2 g c/8 h, ceftazidima 2 g c/8 h, aztreonam 2 g c/8 h, meropenem 1 g c/8 h o imipenem 500 mg c/6 h. Anaerobios solo si se sospecha absceso pulmonar o empiema (condicional, muy baja).[11] Virus respiratorio positivo en NAC grave: dar antibiótico de todos modos (condicional, muy baja).[12]	2019: hasta la estabilidad clínica y no menos de 5 días (fuerte, moderada).[11] 2025: NAC grave estable, ≥5 días (fuerte, baja).[12]
Neumonía intrahospitalaria (NIH) y asociada al ventilador (NAV) IDSA/ATS 2016	NAV: cubrir siempre *S. aureus*, *P. aeruginosa* y otros bacilos gramnegativos (fuerte, baja). NIH: actividad contra *S. aureus* y contra *P. aeruginosa* y gramnegativos (fuertes, muy baja). Opciones: piperacilina-tazobactam 4.5 g c/6 h, cefepima o ceftazidima 2 g c/8 h, imipenem 500 mg c/6 h, meropenem 1 g c/8 h o levofloxacino 750 mg/día (en betalactámicos, la infusión extendida puede ser apropiada). En NAV, evitar aminoglucósidos y colistina si hay alternativas (débiles); en NIH, no usar un aminoglucósido como único antipseudomonas (fuerte). Enfermedad pulmonar estructural (bronquiectasias, fibrosis quística): dos antipseudomonas. Esquema según el antibiograma local de la UCI.[13]	**SARM** (vancomicina 15 mg/kg c/8–12 h, con carga de 25–30 mg/kg en enfermedad grave, o linezolid 600 mg c/12 h): en NAV, con factor de riesgo de resistencia o en unidades con >10–20 % de SARM o sin datos; en NIH, con antibiótico IV en 90 días, unidad con >20 % de SARM o sin datos, o alto riesgo de muerte (ventilación por la NIH o choque séptico). **Dos antipseudomonas de clases distintas**: en NAV, con factor de riesgo de resistencia (antibiótico IV en 90 días, choque séptico al momento de la NAV, SDRA previo, ≥5 días de hospitalización o reemplazo renal agudo previo) o con >10 % de resistencia local o sin datos; en NIH, con antibiótico IV en 90 días o alto riesgo de muerte; sin dos betalactámicos.[13]	7 días (NAV: fuerte, moderada; NIH: fuerte, muy baja); más o menos según la evolución.[13]

FOCO	ESQUEMA EMPÍRICO (GRAVE O EN LA UCI)	MODIFICADORES	DURACIÓN
Infección urinaria (IVU) complicada IDSA 2025	Con sepsis: elegir inicialmente entre **cefalosporina de 3.ª o 4.ª generación** (ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima, cefepima), **carbapenémico**, **piperacilina-tazobactam** o **fluoroquinolona** (ciprofloxacino, levofloxacino), en vez de los fármacos nuevos (nuevas combinaciones de betalactámico con inhibidor, cefiderocol, plazomicina) o aminoglucósidos antiguos (condicional, muy baja a moderada). Sin sepsis, el carbapenémico pasa a alternativa.[14]	Cuatro pasos: gravedad → riesgo de resistencia → factores del paciente (alergias, interacciones) → antibiograma local, solo si hay sepsis. Evitar el fármaco al que hubo un uropatógeno resistente en un urocultivo previo y las fluoroquinolonas si se usaron en los últimos 12 meses (condicionales, muy baja). Elegir un fármaco con susceptibilidad ≥90 % (choque) o ≥80 % (sepsis sin choque) del germen de referencia (urocultivo previo o, si no hay, *E. coli* local); por ejemplo, no usar ceftriaxona empírica si la resistencia local supera 10 % en choque o 20 % en sepsis. Considerar más espectro (*Pseudomonas*, enterococo, SARM) si el diagnóstico no es claro o se sospechan esos gérmenes. Nitrofurantoína y fosfomicina oral no son apropiadas.[14]	Con mejoría y tratamiento eficaz: 5–7 días de fluoroquinolona (condicional, moderada) o 7 días de otro antibiótico (condicional, muy baja); 7 días con bacteriemia por gramnegativos (condicional, baja). Hombres con prostatitis sospechada: pueden beneficiarse de 10–14 días.[15] Paso a vía oral si mejora y hay opción eficaz (condicional, baja; con bacteriemia, muy baja). Los ensayos de duración y de paso a vía oral excluyeron en su mayoría a pacientes con sepsis grave o choque.[15,16]
Infección intraabdominal complicada SIS 2024 (esquemas); IDSA 2024 (riesgo, imagen y microbiología)	Cubrir enterobacterias, cocos grampositivos y anaerobios (1-A). **Cefepima + metronidazol**, **imipenem-cilastatina o meropenem** o **piperacilina-tazobactam** (1-A); el metronidazol es el antianaerobio preferido en combinaciones (1-A). Comunitaria de bajo riesgo: cefotaxima o ceftriaxona + metronidazol, o ertapenem (1-A). No agregar aminoglucósido ni fluoroquinolona al betalactámico en alto riesgo (1-B). Control del foco salvo que haya buenos resultados sin intervención (1-A).[18]	**Alto riesgo** (SIS): sepsis o choque séptico, APACHE II alto, control del foco tardío o inadecuado, infección posoperatoria, peritonitis difusa o comorbilidad importante. Enterococo: cubrirlo en alto riesgo (2-B), no en comunitaria de bajo riesgo (1-B). Vancomicina empírica: no (1-B). Antifúngico empírico: no en comunitaria de alto riesgo (1-B) ni en bajo riesgo (2-B); equinocandina si se sospecha o se prueba *Candida* en enfermedad grave (1-B). Alta prevalencia de BLEE: evitar la mayoría de los esquemas basados en cefalosporina, aztreonam o fluoroquinolona en la comunitaria (1-B); en zonas endémicas de MDR, ertapenem en bajo riesgo o un carbapenémico de amplio espectro en alto riesgo (1-B). Con riesgo de BLEE, la SIS 2024 recomienda ceftazidima-avibactam + metronidazol (1-B) y sugiere ceftolozano-tazobactam (2-B); en contra de combinaciones con aminoglucósido en alto riesgo (1-A).[18] IDSA: hemocultivos si hay fiebre con hipotensión, taquipnea o delirio, o sospecha de resistencia (condicional, muy baja); cultivo intraabdominal si se hace control del foco (condicional, moderada); TC como imagen inicial ante sospecha de absceso; APACHE II para estratificar.[17]	Tras control adecuado del foco: no más de 4 días (1-A); también 4 días en alto riesgo con sepsis o con drenaje percutáneo (1-B). En enfermedad crítica: limitar a 8 días (2-B). Desescalar según cultivos en alto riesgo.[18]

CUANDO LAS GUÍAS NO COINCIDEN

- **Corticoides en NAC grave:** 2019 sugería no usarlos de rutina (condicional, moderada) y remitía a la SSC en el choque séptico refractario.[11] La ATS 2025 sugiere corticoide sistémico en NAC grave (condicional, baja), salvo influenza, y recomienda no darlos en NAC no grave (fuerte, baja); no define fármaco ni duración, aunque el ensayo con resultados más convincentes usó hidrocortisona 200 mg/día en infusión por 4 o 7 días con reducción gradual hasta 8 o 14 días; ese ensayo se centró en la insuficiencia respiratoria y no incluyó pacientes con choque séptico (en el choque rige la SSC).[12] La SSC 2026 sugiere corticoides en todo choque séptico, sin separar la neumonía.[1]

- **Duración en NAC:** 2019 fijaba ≥5 días para todos; en 2025, <5 días (mínimo 3) en NAC no grave estable y ≥5 en NAC grave.[11,12]
- **Intraabdominal:** la SIS 2024 sostiene 4 días tras el control del foco, pero sugiere hasta 8 días en enfermedad crítica. Además define el alto riesgo como APACHE II ">10" en el texto y "≥10" en la tabla de recomendaciones previas.[18] La IDSA 2024 deja la terapia antimicrobiana y el control del foco para partes posteriores.[17]
- **Vancomicina:** 15 mg/kg c/12 h en la guía de NAC; c/8–12 h, con carga, en la de NIH/NAV.[11,13]

5 Reanimación hemodinámica[1,4,7,9]

LÍQUIDOS INICIALES Y MOMENTO DEL VASOPRESOR

PUNTO	QUÉ DICE LA GUÍA
Volumen inicial	Hipoperfusión inducida por sepsis o choque: **al menos 30 mL/kg de cristaloide IV en las primeras 3 h** (condicional, baja; igual que 2016 y 2021). Individualiza y reevalúa con frecuencia para evitar la sub- y la sobrerreanimación. Hipoperfusión: PAM <65, PAS <90, hipotensión relativa (PAS muy por debajo de la basal) o lactato elevado.[1]
Peso para calcular	Peso real; con IMC >30 kg/m², peso ajustado o ideal. En personas caquécticas o de bajo peso, ajusta al peso real. Ejemplos de la tabla 4 (30 mL/kg): 70 kg → 2.1 L; 100 kg y 1.7 m → 2.5 L; 120 kg y 1.5 m → 2.3 L.[1]
Por qué "al menos"	La ESICM sugiere "hasta 30 mL/kg". Para la SSC, la mayoría se beneficia de ≥30 mL/kg y el daño suele aparecer con volúmenes mucho mayores (p. ej., >50 mL/kg; en SSSP-2, ≥70 mL/kg en 6 h).[1]
Vasopresor después del bolo (nueva)	Hipotensión inducida por sepsis: bolo inicial de cristaloide y vasopresor si la hipotensión persiste (condicional, muy baja). **Choque inestable** (PA muy baja, piel moteada o cenicienta, cianosis o desaturación, taquicardia, alteración mental): vasopresor de inmediato junto con los líquidos, caso por caso.[1] **CLOVERS** (1,563 personas con hipotensión por sepsis pese a 1–3 L): estrategia restrictiva (vasopresor primero; 2,134 mL menos en 24 h, diferencia de medianas) vs. liberal; muerte antes del alta a casa al día 90 de 14.0 vs. 14.9 % (diferencia −0.9 puntos; IC 95 % −4.4 a 2.6).[7]
Vía periférica	Iniciar el vasopresor por vena periférica en lugar de esperar el acceso central (condicional, muy baja). Complicaciones: 5.97 %. Usa un protocolo de seguridad (catéter de calidad, vigilancia de extravasación); no hay datos para fijar duración, dosis, calibre ni sitio. "En nuestra práctica", 46.6 % de quienes los usan lo hace hasta por 6 h.[1] Úsala con precaución donde no se pueda vigilar con frecuencia la extravasación.

METAS DE PRESIÓN Y MONITOREO

PAM

- **PAM inicial de 65 mm Hg** en lugar de metas más altas (**fuerte, moderada**). Nueva observación: mantén un rango razonable (p. ej., dentro de 5 mm Hg) y titula el vasopresor para sostenerlo.[1]
- **≥65 años: PAM inicial de 60–65 mm Hg** en lugar de rangos más altos (condicional, baja; nueva). Ensayo 65: mortalidad a 90 días de 41.0 vs. 43.8 %, con menos exposición a vasopresor; metanálisis en ≥65 años: RR 0.89 (certeza alta).[1]

PRESIÓN INVASIVA O NO INVASIVA

- Cualquiera de las dos (condicional, muy baja; en 2021 se sugería la invasiva en cuanto fuera práctico).[1]
- **Invasiva aconsejada** con dosis intermedias o altas, crecientes o varios vasopresores; tomas arteriales frecuentes; o lecturas no invasivas inconsistentes.[1]
- Concordancia no invasiva-invasiva (<10 mm Hg): 73 % para la media. EVERDAC (publicado después de la guía): estrategia no invasiva no inferior.[1]

TIPO Y ESTRATEGIA DE LÍQUIDOS

DECLARACIÓN	DETALLE	FUERZA · CERTEZA
Cristaloides de primera línea	Sin cambio.	Fuerte · moderada
Balanceados en vez de solución salina 0.9 % en la reanimación inicial	Probable menor mortalidad (OR 0.94) y menos terapia de reemplazo renal nueva (OR 0.86, certeza alta). **Traumatismo craneoencefálico:** salina 0.9 %.	Condicional · moderada
Cristaloides solos en vez de cristaloides con albúmina	Sin efecto en mortalidad a 28 días (RR 1.01). La albúmina puede ser apropiada tras grandes volúmenes de cristaloide o en cirrosis; evítala en traumatismo craneoencefálico.	Condicional · moderada

DECLARACIÓN	DETALLE	FUERZA · CERTEZA
Almidones · gelatinas	No usarlos.	Fuerte en contra · alta · Condicional en contra · moderada
Estrategia liberal o restrictiva tras 30 mL/kg con hipoperfusión persistente	Cualquiera, según la persona (p. ej., insuficiencia cardiaca) y el sistema (camas monitorizadas si el enfoque restrictivo exige vasopresor). Sin diferencia en mortalidad (RR 1.00), incluido CLOVERS.[1,7] Con poco acceso a ventilación mecánica, el daño por sobrecarga es mayor.	Condicional · baja
Medidas dinámicas en vez de exploración física o medidas estáticas solas	Elevación pasiva de piernas o reto de líquidos midiendo volumen sistólico o presión de pulso (o sus variaciones; estas, solo en ventilados sin esfuerzo espontáneo); respuesta = aumento de 10–15 %. Mortalidad RR 0.91; menos reemplazo renal (RR 0.75). FC, PVC y PAS predicen mal; la vena cava refleja la PVC.	Condicional · baja
Monitores de gasto cardiaco mínimamente invasivos o no invasivos (nueva)	Evidencia insuficiente.	Sin recomendación

PERFUSIÓN: LACTATO Y LLENADO CAPILAR

QUÉ DICE LA SSC 2026

- **Lactato seriado** para guiar la reanimación en sepsis con lactato elevado o choque (condicional, baja). Individualiza los líquidos tras el bolo inicial según el descenso del lactato; **no sigas dando líquidos hasta normalizarlo**. Se ha asociado con mejores desenlaces una depuración de ≥10 % cada 2 h, aunque el umbral óptimo no está claro.[1]
- **Llenado capilar** como complemento de otras medidas de perfusión (condicional, baja). Puede cambiar en ~10 min, a diferencia del lactato; considera iluminación, temperatura, pigmentación de la piel y enfermedad vascular periférica.[1]
- Dos ECA (233 personas): reanimación hacia llenado ≤3 s vs. lactato cada 2 h; mortalidad a 28 días RR 0.82. Suspender líquidos con llenado ≤3 s pareció seguro.[1]
- **ANDROMEDA-SHOCK-2** (publicado después de la guía; 1,467 personas en las primeras 4 h de choque séptico, 86 centros): protocolo personalizado dirigido al llenado capilar vs. atención habitual. Razón de victorias 1.16 (IC 95 % 1.02–1.33) en el desenlace jerárquico de muerte, días de soporte vital y estancia a 28 días, sobre todo por **menos tiempo de soporte vital**; mortalidad a 28 días 26.5 vs. 26.6 % (HR 0.99; IC 95 % 0.81–1.21).[1,9]

CÓMO INTERPRETAR UN LLENADO PROLONGADO

- **Seis mecanismos que pueden coexistir:** vasoconstricción simpática que desvía flujo de la piel; flujo anterógrado insuficiente (hipovolemia, disfunción ventricular, arritmias, poscarga excesiva); lesión endotelial y microvascular; pérdida de la regulación vasomotora; vasoplejía grave (alteración de la "cascada vascular"); y contrapresión venosa o intersticial (hipotética).[4]
- **No escales el vasopresor solo por un llenado prolongado:** con PAM aceptable puede persistir un gasto bajo.[4]
- **Protocolo de ANDROMEDA-SHOCK-2** (llenado anormal = >3 s, con portaobjetos sobre el pulpejo 10 s): presión de pulso <40 mm Hg → valorar respuesta a volumen y bolo de 500 mL en 30 min si responde; presión de pulso ≥40 con diastólica <50 → norepinefrina hasta diastólica ≥50. Si persiste: ecocardiografía, más volumen solo si responde, prueba de PAM 80–85 mm Hg por 1 h (solo en hipertensos crónicos) y prueba de dobutamina 5 µg/kg/min por 1 h.[9]
- **Úsalo como prueba funcional:** observa su respuesta a la elevación pasiva de piernas, a un reto de líquidos o a un ajuste de la PAM. Si no mejora pese a corregir la variable, probablemente esa variable no es la limitante principal.[4]
- Con fiebre alta, la vasodilatación puede dar un llenado normal pese a hipoperfusión. Estandariza la técnica e intégralo con moteado, temperatura cutánea, diuresis, estado mental y lactato.[4]

VASOPRESORES E INOTRÓPICOS

SITUACIÓN	RECOMENDACIÓN	FUERZA · CERTEZA
Primera línea	**Norepinefrina** sobre dopamina (certeza alta), epinefrina (baja) o selepresina (baja).	Fuerte
Primera línea frente a vasopresina o angiotensina II	Norepinefrina sobre vasopresina (baja) o angiotensina II (muy baja). Vasopresina de primera línea: menos terapia de reemplazo renal (RR 0.70), sin diferencia en mortalidad.	Condicional
Terlipresina	No usarla.	Condicional en contra · baja

SITUACIÓN	RECOMENDACIÓN	FUERZA · CERTEZA
Norepinefrina en ascenso	**Agregar vasopresina.** Mortalidad RR 0.89; menos fibrilación auricular (RR 0.66), posible más isquemia digital (RR 2.87). En VASST, el beneficio se concentró en choque menos grave (norepinefrina <15 µg/min). "En nuestra práctica": se inicia a una mediana de norepinefrina de 0.3 µg/kg/min (RIC 0.2–0.5).	Condicional · moderada
PAM inadecuada con norepinefrina y vasopresina	**Agregar epinefrina.** Sin vasopresina disponible, epinefrina sobre norepinefrina sola. "En nuestra práctica": mediana de norepinefrina de 0.8 µg/kg/min al iniciarla.	Condicional · muy baja
Choque con disfunción cardiaca (nueva)	Norepinefrina o epinefrina como primera línea: norepinefrina si hay taquiarritmia o taquicardia sinusal importante; epinefrina si hay bradiarritmia o bradicardia sinusal importante.	Condicional · muy baja
Disfunción cardiaca con hipoperfusión persistente pese a volumen y PA adecuados	**Inotrópico** en vez de ninguno, siempre además del vasopresor (no en su lugar). Agregar **dobutamina a la norepinefrina** o usar **epinefrina sola**; datos insuficientes para dobutamina vs. milrinona. Levosimendán: no usar (condicional en contra, baja).	Condicional · muy baja
Choque refractario	**Azul de metileno:** evidencia insuficiente (nueva); acorta los días de vasopresor (−1 día, moderada) sin efecto claro en mortalidad; algunas personas con enfermedad tratable podrían valorar un intento. **Midodrina oral** para destetar vasopresores: evidencia insuficiente (nueva).	Sin recomendación
β-bloqueadores (esmolol, landiolol) para tratar el choque (nueva)	No usarlos: menos taquiarritmias nuevas, pero más días de vasopresor (+1.04 días).	Condicional en contra · muy baja

Sin norepinefrina disponible, un consenso Delphi acepta la epinefrina. Sobre el azul de metileno, el texto habla de una recomendación condicional "de usar o no usar", pero la declaración lo clasifica como evidencia insuficiente; aquí se sigue la declaración.[1]

6 Terapias adyuvantes[1]

CORTICOIDES IV EN CHOQUE SÉPTICO (CONDICIONAL, BAJA)

- 45 ECA (9,543 personas): mortalidad a 28 días RR 0.92 y a ≥60 días RR 0.94 (baja); más reversión del choque a 7 días (RR 1.29, alta); más hiperglucemia (RR 1.19) e hipernatremia (RR 1.64).[1]
- El subgrupo de **sepsis sin choque** no mostró beneficio (RR 1.09): la recomendación es para el choque séptico. A diferencia de 2021, la declaración ya no exige "requerimiento continuo de vasopresor".[1,2]
- **Dosis:** la declaración no fija esquema; sin beneficio adicional por encima de 260 mg/día de hidrocortisona. "En nuestra práctica": 90 % usa 200 mg/24 h, 86 % en dosis intermitentes; el momento de inicio varía; 63 % nunca agrega fludrocortisona; 61 % suspende sin reducción gradual.[1]

LO QUE USARON LOS ENSAYOS	POBLACIÓN	ESQUEMA	DESENLACE PRIMARIO
ADRENAL (2018)	Choque séptico con ventilación mecánica y vasopresor o inotrópico ≥4 h; 3,658 analizados.	Hidrocortisona 200 mg/día en **infusión continua**, hasta 7 días o egreso de la UCI.	Mortalidad a 90 días 27.9 vs. 28.8 % (OR 0.95; IC 95 % 0.82–1.10). Resolución del choque más rápida (mediana 3 vs. 4 días).[5]
APROCCHSS (2018)	Choque séptico <24 h con vasopresor ≥0.25 µg/kg/min o ≥1 mg/h por ≥6 h y SOFA 3–4 en ≥2 órganos; 1,241 personas.	Hidrocortisona **50 mg IV en bolo cada 6 h + fludrocortisona 50 µg** por sonda cada mañana, 7 días sin reducción gradual.	Mortalidad a 90 días 43.0 vs. 49.1 % (RR 0.88; IC 95 % 0.78–0.99); a 28 días, 33.7 vs. 38.9 % (p = 0.06). Más hiperglucemia.[6]

Son los esquemas de los ensayos, no recomendaciones de la SSC: la guía no indica dosis ni fludrocortisona.[1,5,6]

TERAPIA	RECOMENDACIÓN SSC 2026	FUERZA · CERTEZA
Antipiréticos (fármacos o enfriamiento externo; nueva)	No usarlos para mejorar desenlaces. No aplica al control del dolor o de síntomas ni a otras indicaciones de control de temperatura (neurocrítico, posparo).	Condicional en contra · muy baja
Vitamina C IV	No usarla (sola o con tiamina y corticoides). Los ensayos de bajo riesgo de sesgo no muestran efecto en la mortalidad; puede causar hiperglucemia ficticia.	Condicional en contra · baja
Tiamina	La guía no emite una recomendación sobre tiamina sola; solo se evaluó dentro de combinaciones con vitamina C.	No abordada
Inmunoglobulina IV	No usarla.	Condicional en contra · baja
Purificación sanguínea	No usar hemoperfusión, hemofiltración de alto volumen ni recambio plasmático (muy baja). Hemoperfusión con polimixina B: no usar (baja).	Condicional en contra
Vitamina D (nueva)	No usarla para tratar la sepsis (en VIOLET, el subgrupo con sepsis tuvo más mortalidad con dosis altas). No aplica a la suplementación habitual.	Condicional en contra · muy baja
Probióticos (nueva)	No usarlos: sin beneficio en los ensayos de bajo riesgo de sesgo.	Condicional en contra · muy baja
XueBiJing (herbolario IV; nueva)	No usarlo fuera de jurisdicciones donde está aprobado.	Condicional en contra · muy baja
Bicarbonato de sodio	Acidemia láctica por hipoperfusión: no usarlo para mejorar la hemodinamia ni reducir vasopresores (baja). **pH ≤7.2 con LRA AKIN 2 o 3:** usarlo (muy baja).	Condicional (ambas)
Transfusión	Estrategia restrictiva en lugar de liberal. La guía 2026 no fija un umbral de hemoglobina.	Fuerte · moderada

7 Ventilación y otros cuidados de soporte[1]

OXIGENACIÓN Y SOPORTE NO INVASIVO (TODAS NUEVAS)

TEMA	RECOMENDACIÓN	FUERZA · CERTEZA
Medir la oxigenación	SpO_2 o gasometría arterial junto con exploración y juicio clínico. La gasometría es el estándar y se prefiere si está disponible. SpO_2/FiO_2 puede sustituir a PaO_2/FiO_2, pero es menos exacta en choque, piel oscura y SpO_2 <90 % o >97 % (en piel oscura sobrestima la saturación).	Condicional · muy baja
Meta de oxígeno en insuficiencia respiratoria hipoxémica	Meta liberal o conservadora según la persona y los recursos. En los ensayos: baja ~90–93 %, alta ≥96 %. Es razonable apuntar a 96–97 % o a 94–95 % aun sin limitación de recursos; con oxígeno escaso, las metas bajas pueden convenir más.	Condicional · baja
Cánula nasal de alto flujo	Sobre oxígeno convencional si PaO_2/FiO_2 <200 o SpO_2/FiO_2 <235 (muy baja); como terapia inicial sobre VMNI (baja); sobre alto flujo alternado con VMNI (muy baja).	Condicional
Prono despierto	Intentarlo en personas no intubadas (menos intubación, RR 0.82); duración según tolerancia; no sedar para lograrlo. Evidencia solo de COVID-19.	Condicional · muy baja

VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA

- **SDRA:** volumen corriente de 6 mL/kg en vez de >10 mL/kg (fuerte, alta); presión meseta ≤30 cm H_2O (fuerte, alta).[1]
- **SDRA moderado a grave:** PEEP alta en vez de baja (condicional, moderada); no usar titulación incremental de PEEP (fuerte en contra, moderada); prono >12 h al día (condicional, moderada); bloqueo neuromuscular en bolos intermitentes en vez de infusión continua (condicional, moderada).[1]
- **Sin SDRA** (nueva): 6–8 mL/kg de peso ideal en vez de 4 a <6 mL/kg (condicional, baja). Busca SDRA con regularidad: no se reconoce en 48.7–52.4 % de quienes cumplen criterios.[1]
- **ECMO venovenosa** si falla la ventilación convencional en SDRA grave, en centros con experiencia (condicional, baja).[1]

OTROS CUIDADOS

- **Profilaxis de úlcera de estrés con IBP** si hay factores de riesgo de sangrado (condicional, moderada): sangrado clínicamente importante RR 0.48. Factores: LRA, sexo masculino, coagulopatía, choque y hepatopatía crónica. Sin IBP, un antagonista H2 es alternativa razonable.[1] **REVISE** (4,821 adultos ventilados, no solo con sepsis): pantoprazol 40 mg IV al día vs. placebo; sangrado digestivo alto clínicamente importante 1.0 vs. 3.5 % (HR 0.30; IC 95 % 0.19–0.47); mortalidad a 90 días 29.1 vs. 30.9 % (HR 0.94; IC 95 % 0.85–1.04).[10]
- **Tromboprofilaxis** farmacológica salvo contraindicación (fuerte, moderada); HBPM sobre heparina no fraccionada (fuerte, moderada); farmacológica sola sobre farmacológica más mecánica (condicional, moderada).[1]
- **Insulina** a partir de glucosa ≥180 mg/dL (10 mmol/L) (fuerte, moderada).[1]
- **Nutrición enteral** temprana, en <72 h (condicional, muy baja).[1]
- **Terapia de reemplazo renal:** no iniciarla sin indicación definitiva (condicional, moderada); continua o intermitente indistintamente (condicional, baja).[1]
- **Retiro activo de líquidos** tras la fase aguda de reanimación (nueva; condicional, muy baja): diuréticos y, si no bastan, ultrafiltración. Pondera función cardiorrespiratoria, dosis de vasopresor, evolución, edema, peso y balance.[1]

8 Metas de cuidado y después del alta[1]

METAS DE CUIDADO Y PALIATIVOS

- Comenta metas de cuidado y pronóstico con la persona y su familia (buena práctica), de forma temprana, en <72 h (condicional, baja).[1]
- Evidencia insuficiente para un criterio estandarizado que dispare esa conversación, para establecer de forma sistemática voluntades anticipadas antes del alta y para los ensayos terapéuticos de tiempo limitado (nueva; 64 % del panel los usa).[1]
- Los sistemas deben dar la oportunidad de otorgar voluntades anticipadas al alta (buena práctica, nueva).[1]
- Integra los principios de cuidados paliativos cuando proceda (buena práctica); interconsulta formal según el juicio clínico, no de rutina para todos (condicional en contra, baja).[1]

TRANSICIONES, ALTA Y RECUPERACIÓN

- Programa de transición al salir de la UCI y entrega estructurada de información (condicionales, muy baja). Tamiza necesidades económicas y sociales (vivienda, alimentación, finanzas, apoyo espiritual) y refiere (buena práctica).[1]
- **Conciliación de medicamentos** en cada transición, incluido el egreso de la UCI y del hospital (buena práctica), de preferencia dirigida por farmacia (condicional, muy baja): menos antipsicóticos y IBP innecesarios.[1]
- Decisión compartida en el egreso; informe escrito y verbal sobre la sepsis y sus secuelas; seguimiento si hay nuevas limitaciones (buenas prácticas).[1]
- Servicios de seguimiento posteriores a la enfermedad crítica (condicional, baja); **rehabilitación física** tras ventilación invasiva >48 h (condicional, baja); servicios de salud mental (condicional, baja) y referencia si hay síntomas (buena práctica).[1]
- Evidencia insuficiente para terapias dirigidas a la cognición, seguimiento temprano vs. habitual, un proceso de egreso multicomponente específico y material educativo para el primer nivel.[1]

9 Qué cambió respecto a 2021[1,2]

TEMA	2021	2026
Tamizaje	En contra de qSOFA como herramienta única frente a SIRS, NEWS o MEWS (fuerte, moderada).	Reformulada a favor de NEWS, NEWS2, MEWS o SIRS sobre qSOFA (fuerte, moderada). Nuevas: tamizaje prehospitalario y "código sepsis".
Hemocultivos	—	Nueva declaración: lo antes posible, idealmente antes del antimicrobiano (fuerte, baja).
Tiempo al antimicrobiano	<1 h en choque posible o sepsis de alta probabilidad (fuerte; certeza baja en choque, muy baja sin choque); <3 h en sepsis posible sin choque (débil, muy baja).	**Sin cambio** en dirección ni fuerza (certeza en choque ahora muy baja). Nuevo: antimicrobiano prehospitalario en sepsis probable o definida con hipotensión si el tiempo previsto hasta la valoración hospitalaria es >60 min (condicional, muy baja).
Control del foco	Buena práctica: lo antes posible.	Condicional, muy baja: idealmente en <6 h.
SARM y gramnegativos	SARM: cubrir en alto riesgo (buena práctica), no en bajo riesgo. Doble cobertura de gramnegativos en alto riesgo de MDR; en contra en bajo riesgo o con patógeno y sensibilidad conocidos.	Una sola pregunta por patógeno MDR específico: cubrir si hay alto riesgo, no si es bajo (condicionales, muy baja). Sin declaración sobre doble cobertura.
Antifúngico empírico	Sugerido en alto riesgo de infección fúngica (débil, baja); en contra en bajo riesgo (débil, baja).	Sugerencia **en contra** de rutina; caso por caso con factores de riesgo (condicional, baja). Nuevas: biomarcadores de *Candida* en contra.
Anaerobios · pruebas rápidas · descontaminación digestiva	—	Nuevas: sin cobertura de anaerobios salvo factores de riesgo; pruebas rápidas caso por caso; descontaminación digestiva selectiva con baja resistencia local.
Infusión prolongada de betalactámicos	Sugerida tras bolo inicial (débil, moderada).	**Recomendada (fuerte)**, tras sumar BLING III al metanálisis.[8]
PK/PD	Buena práctica: usar principios PK/PD.	Monitoreo de concentraciones caso por caso (condicional, muy baja).
Desescalamiento	Evaluación diaria para desescalar en vez de duración fija sin reevaluación (débil, muy baja).	**Fuerte** con microbiología y antibiograma; condicional con cultivos negativos.
Cristaloides balanceados	Sugeridos (débil, baja).	Sugeridos con certeza moderada; salina 0.9 % en traumatismo craneoencefálico.
Albúmina	Sugerida en quien recibió grandes volúmenes de cristaloide (débil, moderada).	Cristaloides solos sobre cristaloides con albúmina (condicional, moderada); albúmina posible tras grandes volúmenes o en cirrosis.
Liberal vs. restrictiva	Evidencia insuficiente.	Cualquiera de las dos (condicional, baja).
Momento del vasopresor	—	Nueva: bolo de cristaloide y luego vasopresor; simultáneo en el choque inestable.
PAM	65 mm Hg sobre metas más altas (fuerte, moderada).	Igual, con rango de ±5 mm Hg; **nueva: 60–65 mm Hg en ≥65 años** (condicional, baja).
Presión arterial	Invasiva en cuanto sea práctico, si hay recursos.	Invasiva o no invasiva (condicional, muy baja), con indicaciones para la invasiva.
Vasopresores	Norepinefrina de primera línea sobre los demás (fuerte; frente a vasopresina, certeza moderada); agregar vasopresina en vez de escalar norepinefrina (débil, moderada); luego epinefrina (débil, baja).	Norepinefrina fuerte frente a dopamina, epinefrina y selepresina, pero condicional frente a vasopresina y angiotensina II. Secuencia vasopresina → epinefrina sin cambio de dirección (epinefrina: certeza baja → muy baja). Nuevas: disfunción cardiaca (norepinefrina o epinefrina), azul de metileno y midodrina (insuficiente), β-bloqueadores en contra.

TEMA	2021	2026
Corticoides	Sugeridos en choque con requerimiento continuo de vasopresor (débil, moderada).	Sugeridos en choque séptico (condicional, baja), sin el requisito de vasopresor continuo.
Purificación sanguínea	Polimixina B en contra (débil, baja); sin recomendación para otras técnicas.	En contra también de hemoperfusión, hemofiltración de alto volumen y recambio plasmático.
Nuevas en contra	—	Antipiréticos para desenlaces, vitamina D, probióticos, XueBiJing.
Respiratorio	Alto flujo sobre VMNI (débil, baja); volumen corriente bajo en toda insuficiencia respiratoria por sepsis sin SDRA (débil).	Nuevas: SpO_2 o gasometría, metas de oxígeno, alto flujo sobre oxígeno convencional y sobre terapia alternada, prono despierto; **sin SDRA, 6–8 mL/kg sobre 4–6 mL/kg**.
Líquidos tardíos	—	Nueva: retiro activo de líquidos tras la fase aguda (condicional, muy baja).
Después del alta	Buenas prácticas y sugerencias de seguimiento; rehabilitación tras ventilación >48 h o UCI >72 h (débil, muy baja); grupos de apoyo de pares.	Rehabilitación solo tras ventilación >48 h (condicional, baja); sin grupos de apoyo de pares. Nuevas buenas prácticas: información para la transición, voluntades anticipadas, apoyo a sobrevivientes y competencia del personal en el seguimiento.

Columna 2021 según la versión 2021 y lo que la guía 2026 dice explícitamente de ella; "débil" es el término que la SSC usaba antes para "condicional"; "—" = la guía 2026 marca la declaración como nueva. La profilaxis de úlcera de estrés se revisó y ahora especifica IBP (incluye el ensayo REVISE[10]). ≥30 mL/kg: revisada, con la misma fuerza y certeza y observaciones nuevas (peso ajustado o ideal si el IMC es >30, reevaluación frecuente). Ventilación en SDRA trasladada, pero el prono >12 h/día baja de fuerte (2021) a condicional (2026). Trasladadas sin cambio de dirección: lactato inicial, ingreso a la UCI en 6 h, procalcitonina, duración corta, almidones y gelatinas, terlipresina, levosimendán, ECMO, bicarbonato (certeza baja → muy baja), transfusión restrictiva, insulina, nutrición, tromboprofilaxis (farmacológica sola: certeza baja → moderada), terapia de reemplazo renal y metas de cuidado. Otras novedades: "la sepsis es un diagnóstico clínico" (buena práctica), pruebas de respuesta del huésped y monitores de gasto cardiaco (evidencia insuficiente), llenado capilar ahora en sepsis y no solo en choque, medidas dinámicas con certeza baja (antes muy baja) y conciliación de medicamentos dirigida por farmacia. Ya no aparecen: maniobras de reclutamiento tradicionales, grupos de apoyo de pares y antivirales.[1,2]

10 Lo que estás haciendo mal

ERRORES FRECUENTES

- **Descartar sepsis porque el qSOFA es <2:** su sensibilidad es baja (23.1 % prehospitalaria). Tamiza con NEWS, NEWS2, MEWS o SIRS.[1]
- **Esperar la procalcitonina para iniciar** el antimicrobiano, o confiar en una sola prueba para descartar sepsis.[1]
- **Retrasar el antimicrobiano en choque** por esperar hemocultivos, el traslado o el catéter central.[1]
- **Dar carbapenémico, vancomicina, antifúngico y metronidazol "por si acaso"** sin factores de riesgo de MDR, hongos o anaerobios: la cobertura innecesaria también daña.[1]
- **Pasar el betalactámico en bolo de 30 min** o iniciar la infusión prolongada sin dosis de carga.[1]
- **Dar líquidos hasta normalizar el lactato**, o calcular 30 mL/kg con el peso real en obesidad.[1]
- **Perseguir una PAM de 75–80 mm Hg** en un adulto mayor: la meta inicial es 65 (60–65 si ≥65 años).[1]
- **Subir la norepinefrina indefinidamente** sin agregar vasopresina, o escalarla solo porque el llenado capilar sigue prolongado sin evaluar gasto cardiaco.[1,4]
- **Dar paracetamol de horario "para que le baje la fiebre"** esperando mejorar el desenlace, o vitamina C, vitamina D o probióticos.[1]
- **Ventilar con >8 mL/kg** sin buscar SDRA: la mitad no se reconoce.[1]
- **Dar de alta sin conciliar medicamentos** (antipsicóticos e IBP iniciados en la UCI) ni plan de seguimiento y rehabilitación.[1]

11 Casos y consulta rápida

Caso 1

Mujer de 72 años, 70 kg, IMC normal, con neumonía adquirida en la comunidad. En urgencias: PA 84/50 mm Hg (PAM 61), FR 20/min, alerta, llenado capilar de 5 s, lactato de 3.4 mmol/L. El qSOFA es de 1 punto.

Respuesta. El qSOFA bajo no descarta nada: hay hipoperfusión inducida por sepsis con posible choque. Hemocultivos de inmediato sin retrasar el antimicrobiano, que debe ir en la primera hora (fuerte). Cristaloide balanceado ≥30 mL/kg (2.1 L) en 3 h con reevaluación; si la hipotensión persiste, norepinefrina por vía periférica con protocolo de seguridad. Por su edad, meta inicial de PAM de 60–65 mm Hg. Sigue el lactato seriado y el llenado capilar; usa medidas dinámicas antes de más líquido. Si requiere UCI, que ingrese en <6 h.[1] Fuera de la SSC: si cumple criterios de NAC grave y no tiene factores de riesgo de SARM o *Pseudomonas*, betalactámico más macrólido (o más fluoroquinolona respiratoria); la ATS 2025 sugiere además corticoide sistémico en NAC grave (no si es influenza).[11,12]

Caso 2

Hombre de 45 años con fiebre de 38.6 °C y FC de 112/min, PA normal, lactato de 1.6 mmol/L. Inició alopurinol hace 3 semanas y tiene un exantema; el examen general de orina es dudoso.

Respuesta. Sepsis posible sin choque: evaluación rápida de causas infecciosas y no infecciosas (reacción farmacológica) y, si persiste la sospecha de infección bacteriana, antimicrobiano en <3 h desde que se sospechó; antes, si la infección se vuelve lo más probable. No uses la procalcitonina para decidir el inicio. Si termina con otro diagnóstico, suspende el antimicrobiano.[1]

Caso 3

Mujer de 58 años con choque séptico por diverticulitis perforada, sin hospitalizaciones ni antibióticos recientes. Tras 30 mL/kg, la norepinefrina sube a 0.3 µg/kg/min con PAM de 62 mm Hg.

Respuesta. Control del foco cuanto antes, idealmente en <6 h: la estabilización prolongada sin control rara vez funciona. Foco intraabdominal: cobertura de anaerobios. Sin factores de riesgo de MDR, no cubras patógenos MDR. El antifúngico no es de rutina; el foco abdominal es un factor de riesgo y se valora caso por caso. Betalactámico (p. ej., piperacilina con tazobactam) con dosis de carga y luego infusión prolongada. Con norepinefrina en ascenso: agrega vasopresina (el panel la inicia a una mediana de 0.3 µg/kg/min) y considera hidrocortisona IV (el panel usa 200 mg/día).[1] Fuera de la SSC: alto riesgo por sepsis (SIS), así que piperacilina-tazobactam o cefepima con metronidazol (carbapenémico si hay alta prevalencia de BLEE); con control adecuado del foco, 4 días de antibiótico (hasta 8 en enfermedad crítica).[18]

Caso 4

Hombre de 66 años en el día 12 de UCI, ventilado, colonizado por *Klebsiella* productora de BLEE, con nuevo choque y sospecha de neumonía asociada al ventilador.

Respuesta. Alto riesgo de un patógeno MDR específico (colonización, hospitalización prolongada): cobertura empírica para ese patógeno (condicional), con apoyo de infectología o microbiología; pruebas rápidas según disponibilidad y programa de optimización. Desescala en cuanto tengas cultivo y antibiograma (fuerte). Si hay choque: antimicrobiano en <1 h y, por su edad, meta inicial de PAM de 60–65 mm Hg. Volumen corriente de 6 mL/kg si cumple criterios de SDRA y de 6–8 mL/kg si no; búscalo de forma activa.[1]

Caso 5

Mujer de 61 años con choque séptico de origen urinario: PAM de 66 mm Hg con norepinefrina, FC de 128/min en ritmo sinusal, llenado capilar de 5 s, presión de pulso de 32 mm Hg. Sin respuesta a la elevación pasiva de piernas; el ecocardiograma muestra FEVI de 25 %.

Respuesta. El llenado prolongado con PAM en meta y presión de pulso baja sugiere flujo anterógrado insuficiente: subir la norepinefrina no es la respuesta y podría empeorarlo por poscarga. Hay disfunción cardiaca con hipoperfusión persistente pese a volumen y PA adecuados: agrega dobutamina a la norepinefrina (o epinefrina sola), siempre sin retirar el vasopresor. Con taquicardia importante, la norepinefrina es preferible a la epinefrina (la guía lo menciona al elegir vasopresor); ojo: la dobutamina también es cronotrópica con FC de 128. Evita el levosimendán. Reevalúa el llenado capilar tras cada ajuste.[1,4]

Caso 6

Hombre de 70 años en el día 5: sin vasopresores, balance de +8 L con edema, cultivos negativos y mejoría clínica. Fue ventilado 4 días. Lleva meropenem desde el ingreso.

Respuesta. Fase posterior a la reanimación aguda: retiro activo de líquidos con diuréticos (condicional). Sin patógeno y con mejoría: desescala (condicional) y usa procalcitonina más clínica para decidir cuándo suspender, con una duración corta. No indiques antipiréticos para mejorar el desenlace. Al egreso: conciliación de medicamentos, información escrita y verbal sobre la sepsis y sus secuelas, seguimiento y rehabilitación física (ventilación >48 h).[1]

CONSULTA RÁPIDA	LO ESENCIAL
Tamizaje	NEWS, NEWS2, MEWS o SIRS; no qSOFA solo. Lactato en toda sospecha.
Primera hora	Hemocultivos → antimicrobiano en <1 h (choque o sepsis probable o definida); <3 h si es posible y sin choque. Control del foco en <6 h.
Antimicrobianos	MDR solo con riesgo específico; sin antifúngico ni anaerobios de rutina; infusión prolongada tras carga; desescalar; duración corta; procalcitonina para suspender.
Por foco (fuera de la SSC)	NAC grave: betalactámico + macrólido o fluoroquinolona; NAV/NIH: cubrir *S. aureus* y *Pseudomonas*, 7 días; IVU con sepsis: cefalosporina de 3.ª–4.ª, carbapenémico, piperacilina-tazobactam o fluoroquinolona; si mejora, 7 días (5–7 con fluoroquinolona), contados desde el primer tratamiento eficaz; intraabdominal: piperacilina-tazobactam, carbapenémico o cefepima + metronidazol, 4 días tras control del foco.
Líquidos	≥30 mL/kg de cristaloide en 3 h (peso ajustado si IMC >30); balanceado; sin albúmina de rutina; nunca almidones; medidas dinámicas.
Vasopresores	Norepinefrina periférica → vasopresina → epinefrina. PAM 65 (60–65 si ≥65 años). Disfunción cardiaca: dobutamina con norepinefrina o epinefrina sola.
Adyuvantes	Hidrocortisona en choque séptico. En contra: vitamina C, vitamina D, inmunoglobulina, purificación, β-bloqueadores, probióticos, antipiréticos para desenlaces. Bicarbonato solo con pH ≤7.2 y LRA AKIN 2–3.
Soporte	Alto flujo si PaO_2/FiO_2 <200 o SpO_2/FiO_2 <235; 6 mL/kg en SDRA y 6–8 sin SDRA; IBP si hay riesgo de sangrado; HBPM; insulina desde 180 mg/dL; nutrición enteral en <72 h.

Superíndices: **1** = Surviving Sepsis Campaign 2026; **2** = Surviving Sepsis Campaign 2021; **3** = Sepsis-3 (Singer, 2016); **4** = Castro y cols., Crit Care 2026; **5** = ADRENAL; **6** = APROCCHSS; **7** = CLOVERS; **8** = BLING III; **9** = ANDROMEDA-SHOCK-2; **10** = REVISE; **11** = ATS/IDSA 2019 (NAC); **12** = ATS 2025 (NAC); **13** = IDSA/ATS 2016 (NIH/NAV); **14–16** = IDSA 2025 (IVU complicada: elección, duración y paso a vía oral); **17** = IDSA 2024 (infección intraabdominal); **18** = SIS 2024 (infección intraabdominal). Fuerza y certeza según GRADE, tal como las reporta la guía; "buena práctica" = declaración de buena práctica (sin calificación de certeza). Las declaraciones "en nuestra práctica" describen lo que hace el panel y no son recomendaciones. Los recuadros "Lo que estás haciendo mal", los casos y la consulta rápida son material educativo propio basado en esas fuentes. En la sección 4, cada guía usa su propia escala de fuerza y calidad.

Referencias

1. Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2026. Crit Care Med 2026;54(4):725–812. doi:10.1097/CCM.0000000000007075. Publicada simultáneamente en Intensive Care Med (doi:10.1007/s00134-026-08361-1).
2. Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. Intensive Care Med 2021;47:1181–1247. doi:10.1007/s00134-021-06506-y
3. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3). JAMA 2016;315:801–810. doi:10.1001/jama.2016.0287
4. Castro R, Kattan E, Urbina T, et al; COPERNICUS Study Group. Capillary refill time prolongation in sepsis and septic shock: supported and potential mechanisms from a pathophysiological perspective. Crit Care 2026 (artículo en prensa). doi:10.1186/s13054-026-06409-8
5. Venkatesh B, Finfer S, Cohen J, et al; ADRENAL Trial Investigators. Adjunctive glucocorticoid therapy in patients with septic shock. N Engl J Med 2018;378:797–808. doi:10.1056/NEJMoa1705835
6. Annane D, Renault A, Brun-Buisson C, et al; CRICS-TRIGGERSEP Network. Hydrocortisone plus fludrocortisone for adults with septic shock. N Engl J Med 2018;378:809–818. doi:10.1056/NEJMoa1705716
7. National Heart, Lung, and Blood Institute Prevention and Early Treatment of Acute Lung Injury Clinical Trials Network; Shapiro NI, Douglas IS, Brower RG, et al. Early restrictive or liberal fluid management for sepsis-induced hypotension. N Engl J Med 2023;388:499–510. doi:10.1056/NEJMoa2212663
8. Dulhunty JM, Brett SJ, De Waele JJ, et al; BLING III Study Investigators. Continuous vs intermittent β-lactam antibiotic infusions in critically ill patients with sepsis: the BLING III randomized clinical trial. JAMA 2024;332:629–637. doi:10.1001/jama.2024.9779
9. ANDROMEDA-SHOCK-2 Investigators for the ANDROMEDA Research Network, SEDAR y LIVEN. Personalized hemodynamic resuscitation targeting capillary refill time in early septic shock: the ANDROMEDA-SHOCK-2 randomized clinical trial. JAMA 2025;334:1988–1999. doi:10.1001/jama.2025.20402
10. Cook D, Deane A, Lauzier F, et al; REVISE Investigators. Stress ulcer prophylaxis during invasive mechanical ventilation. N Engl J Med 2024;391:9–20. doi:10.1056/NEJMoa2404245
11. Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia: an official clinical practice guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. Am J Respir Crit Care Med 2019;200:e45–e67. doi:10.1164/rccm.201908-1581ST

12. Jones BE, Ramirez JA, Oren E, et al. Diagnosis and management of community-acquired pneumonia: an official American Thoracic Society clinical practice guideline. Am J Respir Crit Care Med 2026;212:24–44 (publicada en línea en 2025). doi:10.1164/rccm.202507-1692ST
13. Kalil AC, Metersky ML, Klompas M, et al. Management of adults with hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia: 2016 clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society. Clin Infect Dis 2016;63:e61–e111. doi:10.1093/cid/ciw353
14. Trautner BW, Cortés-Penfield NW, Gupta K, et al. Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America: 2025 guideline on management and treatment of complicated urinary tract infections—selection of antibiotic therapy. Clin Infect Dis 2026;82(Suppl 3):i36–i67. doi:10.1093/cid/ciaf460
15. Trautner BW, Cortés-Penfield NW, Gupta K, et al. IDSA 2025 guidelines on complicated urinary tract infections—duration of antibiotics. Clin Infect Dis 2026;82(Suppl 3):i79–i88. doi:10.1093/cid/ciaf462
16. Trautner BW, Cortés-Penfield NW, Gupta K, et al. IDSA 2025 guidelines on complicated urinary tract infections—timing of intravenous to oral antibiotics transition. Clin Infect Dis 2026;82(Suppl 3):i68–i78. doi:10.1093/cid/ciaf461
17. Bonomo RA, Chow AW, Edwards MS, et al. 2024 clinical practice guideline update by the Infectious Diseases Society of America on complicated intra-abdominal infections: risk assessment, diagnostic imaging, and microbiological evaluation in adults, children, and pregnant people. Clin Infect Dis 2024;79(Suppl 3):S81–S87. doi:10.1093/cid/ciae346
18. Huston JM, Barie PS, Dellinger EP, et al. The Surgical Infection Society guidelines on the management of intra-abdominal infection: 2024 update. Surg Infect (Larchmt) 2024;25:419–435. doi:10.1089/sur.2024.137

SOBRE ESTA GUÍA EN RESUMEN

Medicina en Resumen condensa guías y artículos recientes para médicos. Cada cifra se verifica contra la fuente original. Cuando las guías difieren, lo señalamos. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante. Más guías, artículos explicados y videos en **medicinaenresumen.com** · @medicina.en.resumen